

## Meningite bacteriana no adulto - porta

Suspeita de meningite bacteriana: hemoculturas + antibiótico empírico sem demora. A LP confirma, mas não atrasa o tratamento se houver sinal de alarme ou atraso de imagem.

### Quando TC antes da LP

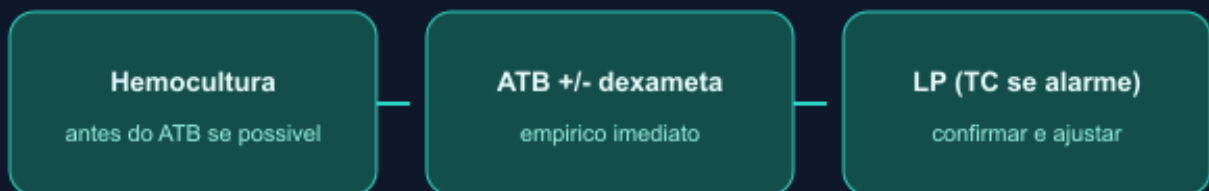
#### Lembre - Quando TC antes da LP

Imunocomprometido, história de SNC, papiledema, déficit focal, convulsão recente ou rebaixamento grave — faça TC antes da LP, mas não atrase ATB.

*Ordem que a prova ama: estabilizar e tratar primeiro; depois documentar LCR quando seguro.*

### Meningite suspeita

ABC -> ATB -> LP / TC



### Empírico clássico (adulto)

- Cefalosporina 3ª (ceftriaxona/cefotaxima) + vancomicina (pneumococo resistente)
- Ampicilina se risco de Listeria (>50 anos, gestante, imunossuprimido, álcool)
- Dexametasona antes ou com a 1ª dose de ATB (benefício no pneumococo)
- Isolamento gotículas até 24 h de ATB eficaz (meningococo)

### LCR — padrões

#### Tipo | Células | Glicose / proteína

Bacteriana | PMN !' | Glicose !" / proteína !'

Viral | Linfó !' | Glicose N / proteína ±

TB/fungo | Linfó !' | Glicose !" / proteína !'!

Listeria | Pode ter linfó | Pensar no contexto

### Armadilha de prova

#### Atenção - Armadilha de prova

Nunca atrase antibiótico esperando TC/LP em meningite fulminante. Profilaxia de contatos no meningococo (rifampicina/cipro/ceftriaxona) conforme protocolo — item clássico.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1